

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC



BÁO CÁO

Nội dung: Sử dụng AI có trách nhiệm trong học tập và nghiên cứu

Học phần: Nhập môn Công nghệ số và Ứng dụng AI

Người thực hiện: Nguyễn Tùng Dương

Lớp: VNU1001_E252023

Hà Nội, 2026

Mục lục

Phần 1: Nghiên cứu chính sách về việc sử dụng AI trong học tập và nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)	4
1.1. Bối cảnh và Các điểm cốt lõi trong chính sách AI của ĐHQGHN	4
1.2. So sánh chính sách của ĐHQGHN với một số Trường Đại học khác tại Việt Nam.....	4
1.3. Nhận định và Góc nhìn cá nhân của tác giả	5
Phần 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập với sự hỗ trợ của AI	6
2.1. Bối cảnh và Xác định nhiệm vụ học tập	6
2.2. Nhật ký tương tác và Chuỗi câu lệnh tinh chỉnh (Iterative Prompting)	6
2.2.1. Prompt 1 - Khởi tạo cấu trúc vĩ mô (System Role & Context):.....	6
2.2.2. Prompt 2 - Thu hẹp phạm vi và tập trung vào bối cảnh bản địa (Context Deepening):	8
2.2.3. Prompt 3 - Phản biện rủi ro (Critical Dialogue):.....	10
2.3. Quá trình Đánh giá, Chỉnh sửa và Đối chiếu nguồn độc lập (Chống ảo giác y khoa)	12
2.4. Trích dẫn sản phẩm AI hợp chuẩn Liêm chính học thuật.....	12
PHẦN 3: Phân tích các vấn đề đạo đức học thuật khi sử dụng AI	13
3.1. Ranh giới của sự "Ủy thác nhận thức" và Nguy cơ dung túng Thiên lệch (Bias)	13
3.2. Đạo đức thông tin: "Ảo giác AI" (Hallucination) và Hiểm họa trong Y khoa ...	13
3.3. Sở hữu trí tuệ và Tính minh bạch của nguồn dẫn chứng (Cross-checking mandate).....	14
Phần 4: Bộ nguyên tắc cá nhân về cách sử dụng AI có trách nhiệm trong học tập	14
4.1. Nguyên tắc 1: Tư duy lâm sàng độc lập và Khách quan (Overcoming Blaming Bias)	14

4.2. Nguyên tắc 2: Hoài nghi lâm sàng tuyệt đối (Zero-Trust in AI Data)	14
4.3. Nguyên tắc 3: Bắt buộc đối chiếu chéo bằng chứng (Evidence-Based Cross-Checking).....	15
4.4. Nguyên tắc 4: Bảo mật thông tin bệnh nhân và Dữ liệu lâm sàng (Medical Privacy Boundaries).....	15
4.5. Nguyên tắc 5: Minh bạch liên chính và Trích dẫn chuẩn mực (Radical Transparency)	15
4.6. Nguyên tắc 6: Giữ vững nguyên tắc "Không làm hại" (Ultimate Ethical Responsibility).....	15
4.7. Tóm tắt bộ nguyên tắc cá nhân bằng Ma trận hành động.....	16
Phần 5: Tạo 1 Infographic minh họa “ Sử dụng AI có trách nhiệm trong học tập ”(Dành cho công cụ Canva).....	16

Phần 1: Nghiên cứu chính sách về việc sử dụng AI trong học tập và nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)

1.1. Bối cảnh và Các điểm cốt lõi trong chính sách AI của ĐHQGHN

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) như ChatGPT, Gemini, Claude bùng nổ, ĐHQGHN đã chủ động tiếp cận theo hướng "**Chủ động thích ứng và định hướng trách nhiệm**" thay vì cấm đoán cực đoan. Minh chứng rõ ràng nhất là việc nhà trường đưa môn học "*Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo*" thành học phần bắt buộc cho toàn bộ sinh viên.

Chính sách và các nguyên tắc cốt lõi của ĐHQGHN về việc sử dụng AI trong học tập và nghiên cứu bao gồm 4 trụ cột chính sau:

1. **AI là công cụ hỗ trợ, không phải thực thể thay thế:** ĐHQGHN công nhận AI là một công cụ đắc lực hỗ trợ sinh viên trong việc: tìm kiếm tài liệu tham khảo, gợi ý ý tưởng (brainstorming), kiểm tra lỗi ngôn ngữ, hoặc tối ưu hóa quy trình tìm kiếm tri thức. AI được xem như một "trợ lý học tập" thúc đẩy năng lực tự học.
2. **Nguyên tắc không thay thế tư duy và năng lực cá nhân:** Đây là ranh giới đỏ cấu thành liêm chính học thuật. Sinh viên **không được phép** sử dụng AI để làm thay toàn bộ bài tập, bài luận, tiểu luận, thuyết trình, hay khóa luận tốt nghiệp. Mọi sản phẩm học tập được nộp và đánh giá phải phản ánh đúng năng lực và tư duy độc lập của người học.
3. **Sự minh bạch và trung thực học thuật:** Khi sử dụng AI để hỗ trợ thu thập dữ liệu hoặc gợi ý cấu trúc, sinh viên có trách nhiệm phải khai báo minh bạch. Điều này bao gồm việc trích dẫn nguồn từ AI một cách hợp chuẩn (ví dụ theo chuẩn APA) và sẵn sàng giải trình về chuỗi câu lệnh (prompt) cũng như cách thức tích hợp công cụ này vào bài làm khi giảng viên yêu cầu.
4. **Trách nhiệm học thuật tối cao thuộc về người học:** Do AI có hiện tượng "ảo giác" (hallucination - đưa ra thông tin sai lệch nhưng với phong thái thuyết phục), ĐHQGHN quy định sinh viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, tính pháp lý và tính đạo đức của mọi thông tin xuất hiện trong bài nộp cuối cùng của mình.

1.2. So sánh chính sách của ĐHQGHN với một số Trường Đại học khác tại Việt Nam

Để làm nổi bật tính đặc thù trong cách tiếp cận của ĐHQGHN, chúng ta tiến hành so sánh với chính sách AI của **Đại học RMIT Việt Nam** và **Đại học VinUni** – hai đơn vị có những tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về liêm chính học thuật.

- **Về mức độ cho phép sử dụng:**

- **ĐHQGHN:** Cho phép sử dụng rộng rãi như công cụ hỗ trợ tư duy và tăng cường năng lực số, kết hợp giáo dục bắt buộc thông qua môn học nền tảng.

- **RMIT & VinUni:** Cho phép sử dụng có điều kiện. Quy định cụ thể mức độ được dùng AI theo từng môn học (course-by-course) hoặc thậm chí theo từng bài tập cụ thể dưới sự chỉ định nghiêm ngặt của giảng viên phụ trách.
- **Về yêu cầu minh bạch và kỹ thuật trích dẫn:**
 - **ĐHQGHN:** Nhấn mạnh vào tinh thần tự giác minh bạch và khả năng giải trình khi có yêu cầu kiểm tra đạo văn hoặc chất vấn trực tiếp từ hội đồng thẩm định.
 - **VinUni & RMIT:** Áp dụng bộ quy tắc kỹ thuật rất chi tiết (AI Competency Framework). Sinh viên bắt buộc phải đính kèm phần cam đoan (Acknowledgement), nêu rõ tên công cụ AI, phiên bản (ví dụ: GPT-4o), mục đích sử dụng (tóm tắt ý hay sửa ngữ pháp), và trong một số trường hợp phải kê khai tỷ lệ phần trăm nội dung có sự can thiệp của AI. Việc dùng AI mà không khai báo được đánh giá trực tiếp là lỗi Đạo văn (Plagiarism) và chịu chế tài kỷ luật nặng.

Đánh giá chung: Chính sách của ĐHQGHN mang tính vĩ mô, tập trung vào việc kiến tạo năng lực gốc cho sinh viên để họ tự ý thức và làm chủ công nghệ. Trong khi đó, các trường đại học quốc tế như RMIT hay VinUni lại đi sâu vào các chế tài kỹ thuật chi tiết, quản lý chặt chẽ theo từng đầu điểm bài tập để kiểm soát rủi ro gian lận trực diện.

1.3. Nhận định và Góc nhìn cá nhân của tác giả

Dưới góc nhìn của một sinh viên đang trực tiếp học tập trong hệ thống ĐHQGHN, em đánh giá chính sách hiện tại mang tính **nhân văn, tiến bộ và thực tế**. Việc không lựa chọn con đường "bọc lòng kính" cấm đoán AI là một quyết định đúng đắn, bởi AI đã trở thành một kỹ năng sinh tồn không thể thiếu của nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số. Việc ĐHQGHN chuẩn hóa năng lực AI của sinh viên ngay từ năm nhất thông qua môn học bắt buộc giúp san phẳng khoảng cách công nghệ giữa các vùng miền và ngành học.

Tuy nhiên, từ thực tế triển khai, em nhận thấy một số **thách thức và khoảng cách** cần được hoàn thiện:

- **Tính đồng bộ trong đánh giá:** Dù có khung chính sách chung, nhưng mức độ hiểu và chấp nhận AI của các giảng viên giữa các khoa/trường thành viên (ví dụ giữa khối Khoa học Tự nhiên và Khối Khoa học Xã hội & Nhân văn) vẫn có sự chênh lệch lớn. Một số giảng viên cởi mở cho sinh viên dùng AI dịch tài liệu, trong khi số khác vẫn hoài nghi và chấm điểm khắt khe nếu nghi ngờ có "mùi chữ" AI.
- **Sự thiếu hụt của các công cụ kiểm soát định lượng:** Hiện tại, nhà trường chưa phổ biến rộng rãi một bộ quy chuẩn định lượng (như phần mềm phát hiện AI chuyên dụng) mà chủ yếu dựa vào đánh giá định tính của giảng viên thông qua các bài văn đáp hoặc thuyết trình bảo vệ.

Kết luận: Chính sách của ĐHQGHN đã xây dựng được phần "nền móng" tư duy rất tốt. Để đạt hiệu quả tối ưu trong giai đoạn tiếp theo, nhà trường cần cụ thể hóa các hướng dẫn bằng các bộ tiêu chí định lượng rõ ràng hơn cho từng dạng bài tập (bài luận, viết code, nghiên cứu định lượng) nhằm giúp cả giảng viên lẫn sinh viên dễ dàng thực thi quyền và trách nhiệm của mình một cách công bằng nhất.

Phần 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập với sự hỗ trợ của AI

2.1. Bối cảnh và Xác định nhiệm vụ học tập

- **Nhiệm vụ học tập:** Lập dàn ý chi tiết và tìm kiếm cơ sở lý luận y khoa cho bài tiểu luận môn Giáo dục Sức khỏe/Dược lý lâm sàng.
- **Chủ đề cụ thể:** *"Thực trạng lạm dụng nhóm thuốc Corticoid trong cộng đồng tại Việt Nam: Nguyên nhân, rủi ro sức khỏe và giải pháp can thiệp."*
- **Công cụ AI sử dụng:** ChatGPT (Phiên bản GPT-4o) / Gemini.
- **Mục tiêu ứng dụng:** Sử dụng AI để hệ thống hóa kiến thức y khoa phức tạp thành dàn ý logic, gợi ý các từ khóa chuyên ngành (Medical terms) để phục vụ cho việc tra cứu tài liệu học thuật sau này.

2.2. Nhật ký tương tác và Chuỗi câu lệnh tinh chỉnh (Iterative Prompting)

Để đảm bảo tính chính xác khoa học, tôi không dùng một câu lệnh duy nhất mà áp dụng kỹ thuật "**Prompting lặp**" qua 3 bước để định hướng AI:

2.2.1. Prompt 1 - Khởi tạo cấu trúc vĩ mô (System Role & Context):

- **Câu lệnh (Prompt 1):** "Hãy đóng vai là một chuyên gia Dược tế học và Giảng viên Y khoa lâm sàng. Tôi là sinh viên năm 4 khối ngành Khoa học sức khỏe tại Việt Nam. **Yêu cầu:** Xây dựng một dàn ý tiểu luận học thuật (gồm 3 phần chính) về chủ đề: 'Thực trạng lạm dụng nhóm thuốc Corticoid trong cộng đồng tại Việt Nam: Nguyên nhân, Hậu quả và Can thiệp'. **Ràng buộc:** > 1. Sử dụng thuật ngữ y khoa chuẩn xác. 2. Phân tích nguyên nhân theo mô hình đa chiều (từ thói quen bệnh nhân đến lỗ hổng quản lý dược). 3. Tuyệt đối không tự tạo (bịa) số liệu thống kê. Nếu cần dẫn chứng, hãy để trống và ghi chú [Cần chèn số liệu thực tế]. Trình bày dưới định dạng Markdown."
- **Kết quả từ AI:** AI đưa ra một dàn ý chuẩn mực nhưng nặng về lý thuyết dược lý chung (Cơ chế hoạt động, Tác dụng phụ, Cách phòng ngừa), chưa có tính thực tiễn tại Việt Nam.

Hãy đóng vai là một chuyên gia Dược tế học và Giảng viên Y khoa lâm sàng. Tôi là sinh viên năm 4 khối ngành Khoa học sức khỏe tại Việt Nam. Yêu cầu: Xây dựng một dàn ý tiểu luận học thuật (gồm 3 phần chính) về chủ đề: 'Thực trạng lạm dụng nhóm thuốc Glucocorticoid trong cộng đồng tại Việt Nam: Nguyên nhân, Hậu quả và Can thiệp'. Ràng buộc: > 1. Sử dụng thuật ngữ y khoa chuẩn xác. 2. Phân tích nguyên nhân theo mô hình đa chiều (từ thói quen bệnh nhân đến lỗ hổng quản lý dược). 3. Tuyệt đối không tự tạo (bịa) số liệu thống kê. Nếu cần dẫn chứng, hãy để trống và ghi chú [Cần chèn số liệu thực tế]. Trình bày dưới định dạng Markdown

Chào em, một sinh viên Y4 đầy triển vọng. Ở năm thứ 4, em đã bắt đầu bước chân vào các bệnh viện lâm sàng và tiếp xúc với các ca bệnh thực tế. Việc chọn đề tài về Dược tế học lâm sàng đối với nhóm thuốc Glucocorticoid (Corticoid) tại thời điểm này là vô cùng chín muồi và có giá trị thực tiễn cao.

Dưới góc độ của một Giảng viên Lâm sàng và Chuyên gia Dược tế học, tôi đánh giá cao cách tiếp cận chuyên nghiệp của em qua câu lệnh này. Dưới đây là dàn ý tiểu luận học thuật được thiết kế nghiêm ngặt theo mô hình hệ thống và đa chiều, đáp ứng hoàn toàn các ràng buộc em đã đưa ra:

ĐỀ CƯƠNG TIỂU LUẬN HỌC THUẬT

TIÊU ĐỀ ĐỀ XUẤT:

Thực trạng lạm dụng nhóm thuốc Glucocorticoid trong cộng đồng tại Việt Nam: Phân tích hệ thống từ góc độ Dược tế học và Chiến lược can thiệp lâm sàng.

MỞ ĐẦU

- **Bối cảnh Dược lý học:** Định vị Glucocorticoid là nhóm thuốc điều trị phổ rộng (chống viêm, ức chế miễn dịch, chống dị ứng) - một phát kiến vĩ đại nhưng là "con dao hai lưỡi" sắc bén trong y

MỞ ĐẦU

- **Bối cảnh Dược lý học:** Định vị Glucocorticoid là nhóm thuốc điều trị phổ rộng (chống viêm, ức chế miễn dịch, chống dị ứng) - một phát kiến vĩ đại nhưng là "con dao hai lưỡi" sắc bén trong y khoa.
- **Tính cấp thiết của đề tài:** Tình trạng dịch chuyển từ một thuốc kê đơn nghiêm ngặt (Prescription-only medicine - Rx) thành một chất bị lạm dụng tự do trong cộng đồng tại Việt Nam, dẫn đến các hệ lụy lâm sàng nghiêm trọng.
- **Mục tiêu tiểu luận:** Nhận diện các hình thức lạm dụng, bóc tách căn nguyên theo mô hình đa tầng và đề xuất giải pháp can thiệp dựa trên bằng chứng (Evidence-based intervention).

PHẦN 1: BỨC TRANH DƯỢC TẾ HỌC VỀ THỰC TRẠNG LẠM DỤNG CORTICOID TẠI VIỆT NAM

1.1. Các hình thức lạm dụng Corticoid phổ biến trong cộng đồng

- **Lạm dụng qua đường toàn thân (Systemic Corticosteroids):** * Tự ý sử dụng các thuốc chứa Dexamethasone, Prednisolone, Methylprednisolone dưới dạng viên nén để điều trị các triệu chứng hô hấp cấp tính thông thường (ho, viêm họng) hoặc hội chứng đau xương khớp mạn tính.
- **Lạm dụng qua đường dùng ngoài (Topical Corticosteroids):**
 - Sử dụng các corticoid hàm lượng cao (như Clobetasol propionate, Betamethasone) trộn trộn trong các sản phẩm không nhãn mác ("kem trộn", mỹ phẩm làm trắng da cấp tốc) gây độc tính tại chỗ.
- **Lạm dụng qua hình thức Đông - Tây y kết hợp bất hợp pháp:**
 - Hiện tượng tán nhỏ Corticoid trộn vào các viên "thuốc tể", "thuốc hoàn" Đông y không rõ nguồn gốc nhằm tạo hiệu ứng giảm đau, tăng cân giả tạo cho người già và trẻ em.

1.2. Phân bố tế học và Nhóm đối tượng đích rủi ro cao

- **Nhóm Nhi khoa:** Trẻ em bị lạm dụng Corticoid qua các bài thuốc truyền tay hoặc si rô ho tự chế để dứt triệu chứng nhanh. [Cần chèn số liệu thực tế về tỷ lệ trẻ nhập viện do biến chứng Corticoid].
- **Nhóm Người cao tuổi:** Bệnh nhân mắc các bệnh lý xương khớp mạn tính (Thoái hóa khớp, Viêm khớp dạng thấp).
- **Nhóm Phụ nữ độ tuổi sinh sản:** Đối tượng chính của các sản phẩm làm đẹp chứa Corticoid lậu. [Cần chèn số liệu thực tế từ các bệnh viện da liễu].

PHẦN 2: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN ĐA CHIỀU VỀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ HẬU QUẢ LÂM SÀNG

2.1. Phân tích nguyên nhân theo mô hình đa chiều (Multi-dimensional Model)

- **Tầng vĩ mô (Macro - Chính sách và Quản lý Dược):**
 - Lỗ hổng trong việc thực thi quy chế bán thuốc kê đơn (Rx) tại các nhà thuốc GPP (Good Pharmacy Practices). Việc mua kháng sinh và corticoid không cần đơn vẫn còn diễn ra phổ biến.
 - Thách thức trong việc quản lý và kiểm soát thị trường mỹ phẩm, thực phẩm chức năng xuyên biên giới và trên các nền tảng thương mại điện tử.
- **Tầng trung mô (Meso - Hệ thống y tế và Cung ứng):**
 - Áp lực doanh thu của các nhà thuốc bán lẻ dẫn đến việc dược sĩ tá viên lạm dụng việc phối hợp Corticoid trong các "liều thuốc liều" (liều cắt sẵn) để tạo hiệu quả điều trị tức thì.
 - Sự phân bổ và tiếp cận y tế cơ sở chưa đồng đều, khiến người dân có xu hướng chọn nhà thuốc thay vì đi khám bác sĩ.
- **Tầng vi mô (Micro - Hành vi và Nhận thức cộng đồng):**
 - *Hội chứng lười biếng nhận thức (Cognitive laziness):* Tâm lý sinh "thuốc nhay", dứt triệu chứng nhanh của người bệnh mà không quan tâm đến cơ chế bệnh sinh.
 - Thiếu hụt nghiêm trọng kiến thức về chăm sóc sức khỏe (Health literacy), thói quen tự làm bác sĩ và chia sẻ đơn thuốc cũ cho người khác.

2.2. Hậu quả lâm sàng và Gánh nặng Y tế Công cộng

- **Độc tính hệ thống và Biến chứng nội tiết:**
 - **Hội chứng Cushing do thuốc (Exogenous Cushing's syndrome):** Kiểu hình đặc trưng (mặt tròn như mặt trăng, béo trung tâm, rậm lông, teo cơ gốc chi).
 - **Suy tuyến thượng thận thứ phát (Secondary Adrenal Insufficiency):** Sự ức chế trục Hạ đồi - Tuyến yên - Tuyến thượng thận (Trục HPA). Nguy cơ xảy ra cơn suy thượng thận cấp (Adrenal crisis) đe dọa tính mạng khi ngừng thuốc đột ngột. [Cần chèn số liệu thực tế về ca lâm sàng suy thượng thận cấp do corticoid].
- **Biến chứng trên các cơ quan khác:**
 - *Cơ xương khớp:* Loãng xương thứ phát (Osteoporosis), hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi (Avascular necrosis). Tình trạng chậm phát triển chiều cao rõ rệt ở trẻ em.
 - *Chuyển hóa & Miễn dịch:* Đái tháo đường do steroid, tăng huyết áp, che lấp các dấu hiệu nhiễm trùng lâm sàng dẫn đến nhiễm khuẩn huyết.
 - *Da liễu (tại chỗ):* Nghiện Corticoid bôi ngoài da (Topical Steroid Addiction), teo da, rạn da, giãn mao mạch.

PHẦN 3: CHIẾN LƯỢC CAN THIỆP VÀ GIẢI PHÁP DƯỢC TẾ HỌC HỆ THỐNG

2.2.2. Prompt 2 - Thu hẹp phạm vi và tập trung vào bối cảnh bản địa (Context Deepening):

- **Câu lệnh (Prompt 2):** "Dựa vào dàn ý vừa lập, hãy tiến hành tinh chỉnh sâu phần 'Thực trạng & Nguyên nhân'. **Yêu cầu cụ thể:** > 1. Xoáy sâu vào 2 vấn nạn đặc thù tại y tế cơ sở Việt Nam: (A) Tự ý mua thuốc Corticoid không kê đơn (OTC) cho trẻ em mắc bệnh hô hấp tại các nhà thuốc tư nhân; (B) Vấn nạn lạm dụng Corticoid bôi ngoài da (Topical Corticosteroids) trong 'kem trộn' mỹ phẩm. 2. Cung cấp kèm theo các từ khóa y khoa chuẩn quốc tế (MeSH terms - Medical Subject Headings) tương ứng cho từng luận điểm để tôi có thể dùng chúng tra cứu tài liệu độc lập trên cơ sở dữ liệu PubMed và Cochrane."
- **Kết quả từ AI:** AI đã tối ưu hóa dàn ý, bổ sung các tiểu mục rất sát với thực tế y tế công cộng tại Việt Nam (như Hội chứng Cushing do thuốc, teo da do kem trộn, suy tuyến thượng thận cấp).

Dựa vào dàn ý vừa lập, hãy tiến hành tinh chỉnh sâu phần 'Thực trạng & Nguyên nhân'. Yêu cầu cụ thể: > 1. Xoáy sâu vào 2 vấn nạn đặc thù tại y tế cơ sở Việt Nam: (A) Tự ý mua thuốc Corticoid không kê đơn (OTC) cho trẻ em mắc bệnh hô hấp tại các nhà thuốc tư nhân; (B) Vấn nạn lạm dụng Corticoid bôi ngoài da (Topical Corticosteroids) trong 'kem trộn' mỹ phẩm. 2. Cung cấp kèm theo các từ khóa y khoa chuẩn quốc tế (MeSH terms - Medical Subject Headings) tương ứng cho từng luận điểm để tôi có thể dùng chúng tra cứu tài liệu độc lập trên cơ sở dữ liệu PubMed và Cochrane



Chào em, việc lựa chọn xoáy sâu vào hai vấn nạn này chứng tỏ em có nhãn quan lâm sàng và tư duy dịch tễ học rất sắc bén. Đây chính là hai "điểm nóng" phản ánh chính xác thực trạng hệ thống y tế và hành vi sử dụng thuốc đặc thù tại Việt Nam, nơi ranh giới giữa thuốc kê đơn và không kê đơn bị xóa nhòa nhiều nhất.

Dưới góc độ chuyên môn, tôi tiến hành tinh chỉnh sâu phần **Thực trạng & Nguyên nhân** trong đề cương của em, đồng thời cung cấp hệ thống từ khóa **MeSH Terms** chuẩn quốc tế để em xây dựng phần Tổng quan tài liệu (Literature Review) đạt chuẩn quốc tế.

TINH CHỈNH SÂU PHẦN 1: THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN LẠM DỤNG CORTICOID

1.1. Luận điểm A: Tự ý sử dụng Glucocorticoid đường toàn thân điều trị nhiễm khuẩn hô hấp nhi khoa tại các nhà thuốc tư nhân (Grassroots Pharmacies)

- **Thực trạng lâm sàng và dịch tễ:**
 - **Hành vi phổ biến:** Khi trẻ em có các triệu chứng hô hấp cấp tính (ho, khó khè, sốt, viêm họng, viêm phế quản), phụ huynh thường tự ý đến thẳng nhà thuốc tư nhân thay vì đi khám bác sĩ nhi khoa.
 - **Thực trạng "Cắt liều":** Để đạt hiệu quả cắt triệu chứng nhanh nhằm giữ khách và tạo uy tín "thuốc nhay", nhiều dược sĩ/nhân viên bán thuốc tại y tế cơ sở đã tự ý phối hợp các Glucocorticoid đường uống mạnh (thường gặp nhất là Dexamethasone, Prednisolone hoặc Methylprednisolone) vào các liều thuốc cắt sẵn (thường được nghiền nhỏ hoặc đóng gói theo ngày) phối hợp cùng kháng sinh và kháng histamin.
 - **Hậu quả tích lũy:** Việc lạm dụng lặp đi lặp lại các đợt Corticoid ngắn ngày nhưng liều cao và không có phác đồ giảm liều (Tapering) ở trẻ em dẫn đến tình trạng suy tuyến thượng thận thứ phát tiềm ẩn, ức chế trục HPA, hội chứng Cushing nhi khoa, loãng xương, chậm phát triển chiều cao rõ rệt và suy giảm miễn dịch, làm bùng phát các nhiễm khuẩn hô hấp nặng hơn. [Cần chèn số liệu thực tế về tỷ lệ trẻ em nhập viện vì suy tuyến thượng thận do thuốc tại các BV Nhi lớn].
- **Phân tích nguyên nhân đặc thù:**
 - *Tâm lý phụ huynh:* Áp lực chăm con, nôn nóng muốn trẻ hết ho/sốt ngay lập tức để đi học lại, dẫn đến chuộng các nhà thuốc "mắt tay" (thực chất là lạm dụng corticoid liều cao).
 - *Lỗ hổng thương mại & Chuyên môn:* Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà thuốc tư nhân dẫn đến việc ưu tiên doanh thu và hiệu quả tức thì hơn là an toàn người bệnh. Nhân viên đứng quầy tại nhiều cơ sở là dược sĩ trung học hoặc tá viên thiếu kiến thức sâu về dược lý lâm sàng và cảnh giác được.

- o Hệ thống từ khóa MeSH phục vụ tra cứu (PubMed/Cochrane):
 - o Adrenal Cortex Hormones / adverse effects (Corticoid / tác dụng phụ)
 - o Self Medication / statistics & numerical data (Tự ý dùng thuốc / số liệu thống kê)
 - o Respiratory Tract Infections / drug therapy (Nhiễm khuẩn hô hấp / điều trị bằng thuốc)
 - o Pediatrics (Nhi nội)
 - o Pharmacies / legislation & jurisprudence (Nhà thuốc / luật pháp và quản lý)
 - o Vietnam (B bối cảnh Việt Nam)
 - o Chuỗi lệnh tìm kiếm gợi ý trên PubMed: ("Self Medication"[Mesh] AND "Adrenal Cortex Hormones"[Mesh] AND "Respiratory Tract Infections"[Mesh] AND "Vietnam")
- 1.2. Luận điểm B: Vấn nạn lạm dụng Glucocorticoid dùng ngoài (Topical Corticosteroids) thông qua thị trường mỹ phẩm tự chế ("Kem trộn")
- o Thực trạng lâm sàng và dịch tễ:
 - o Cơ chế đánh lừa của Corticoid: Các dẫn xuất Corticoid phân nhóm siêu mạnh (Very potent - Nhóm I như Clobetasol propionate) hoặc mạnh (Potent - Nhóm II như Betamethasone dipropionate) bị lén lút trộn vào các sản phẩm kem dưỡng da, kem trị mụn tự chế không nhãn mác (thường gọi là "kem trộn"). Do tác dụng co mạch (làm da trắng ảo nhanh) và kháng viêm mạnh (làm lặn mụn cấp tốc), các sản phẩm này tạo ra hiệu ứng thẩm mỹ thần tốc trong vài ngày đầu.
 - o Hội chứng "Nghiện" và Biến chứng: Khi người dùng sử dụng kéo dài, hàng rào bảo vệ da bị phá hủy hoàn toàn. Khi ngưng thuốc, hiện tượng dội ngược (Rebound phenomenon) xảy ra dữ dội khiến da bùng phát mụn trứng cá dạng steroid, giãn mao mạch diện rộng, teo da, rạn da, tăng sắc tố sau viêm và nhiễm trùng da thứ phát. Việc điều trị phục hồi các ca này kéo dài từ vài tháng đến vài năm và để lại di chứng thẩm mỹ vĩnh viễn. [Cần chèn số liệu tỷ lệ bệnh nhân biến chứng da do kem trộn đến khám tại BV Da Liễu].
 - o Phân tích nguyên nhân đặc thù:
 - o Áp lực văn hóa & Thẩm mỹ: Định kiến xã hội chuộng làn da "trắng hồng cấp tốc", đẩy người tiêu dùng (đặc biệt là học sinh, sinh viên, phụ nữ nông thôn) vào các giải pháp làm đẹp giá rẻ, nhanh chóng.
 - o Sự bùng nổ của TMDT và "Bác sĩ tự phong": Sự lỏng lẻo trong quản lý bán hàng online (Facebook, TikTok, Shopee...) cho phép các cơ sở sản xuất kem trộn chui dễ dàng tiếp cận khách hàng qua các chiến dịch livestream, quảng cáo sai sự thật. Hệ thống quản lý thị trường và kiểm nghiệm mỹ phẩm hiện tại chưa theo kịp tốc độ biến tướng của thị trường này.
 - o Hệ thống từ khóa MeSH phục vụ tra cứu (PubMed/Cochrane):
 - o Administration, Topical / adverse effects (Dùng ngoài da / tác dụng phụ)
 - o Glucocorticoids / administration & dosage (Glucocorticoid / đường dùng và liều lượng)
 - o Cosmetics / toxicity (Mỹ phẩm / độc tính)
 - o Skin Diseases / chemically induced (Bệnh da liễu / do hóa chất gây ra)
 - o Dermatitis, Contact (Viêm da tiếp xúc)

2.2.3. Prompt 3 - Phản biện rủi ro (Critical Dialogue):

- o **Câu lệnh (Prompt 3):** "Bây giờ, hãy chuyển sang vai trò là một thành viên khó tính trong Hội đồng Phản biện Đạo đức Y khoa. **Yêu cầu:** Hãy đánh giá toàn bộ dàn ý trên và chỉ ra:
 1. Hai lỗ hổng logic hoặc nguy cơ đánh tráo khái niệm (bias) mà tôi dễ mắc phải khi triển khai bài luận này.
 2. Xác định rõ những luận điểm nào trong dàn ý dễ bị ảnh hưởng bởi 'ảo giác AI' (Hallucination) nhất.
 3. Đề xuất cho tôi 3 nguồn tài liệu chính thống (như văn bản pháp quy, Dược thư...) mà tôi bắt buộc phải tra cứu để đối chiếu chéo (Cross-check) thông tin. Trình bày ngắn gọn dưới dạng gạch đầu dòng."
- o **Kết quả từ AI:** AI tự cảnh báo rằng bài luận không được phép đưa ra phác đồ "cai" Corticoid cho bệnh nhân (vì đây là việc của bác sĩ lâm sàng), mà chỉ nên dừng lại ở góc độ cảnh báo sức khỏe cộng đồng và nâng cao nhận thức.

o Bây giờ, hãy chuyển sang vai trò là một thành viên khó tính trong Hội đồng Phản biện Đạo đức Y khoa. Yêu cầu: Hãy đánh giá toàn bộ dàn ý trên và chỉ ra:

1. Hai lỗ hổng logic hoặc nguy cơ đánh tráo khái niệm (bias) mà tôi dễ mắc phải khi triển khai bài luận này.
2. Xác định rõ những luận điểm nào trong dàn ý dễ bị ảnh hưởng bởi "ảo giác AI" (Hallucination) nhất. Đề xuất cho tôi 3 nguồn tài liệu chính thống (như văn bản pháp quy, Dược thư...) mà tôi bắt buộc phải tra cứu để đối chiếu chéo (Cross-check) thông tin. Trình bày ngắn gọn dưới dạng gạch đầu dòng.

Chào em. Với tư cách là một ủy viên của Hội đồng Phản biện Đạo đức Y khoa, tôi ghi nhận sự nghiêm túc của em trong việc xây dựng đề cương. Tuy nhiên, dưới góc độ học thuật và đạo đức nghiên cứu, một đề cương hay vẫn có thể dẫn đến một bài luận sai lệch nếu người viết thiếu sự tỉnh táo.

Dưới đây là những đánh giá phản biện khắt khe dành cho đề cương của em:

1. Hai lỗ hổng logic và nguy cơ đánh tráo khái niệm (Bias) cần tránh

- o **Nguy cơ thứ nhất: Đánh tráo khái niệm giữa "Tác dụng phụ tất yếu" (ADR) và "Hậu quả do lạm dụng"**
 - o *Phân tích:* Corticoid bản chất là một loại thuốc có độc tính cao. Ngay cả khi bác sĩ kê đơn hoàn toàn đúng chỉ định (ví dụ: điều trị Lupus ban đỏ hay Hội chứng thận hư), bệnh nhân vẫn có thể bị Hội chứng Cushing hay loãng xương.
 - o *Khuyến nghị:* Em rất dễ rơi vào bẫy quy chụp mọi ca bệnh Cushing hay suy thượng thận đều là do "lạm dụng" hoặc "kém hiểu biết". Em cần rạch ròi ranh giới này trong bài luận: Đây là tổn thương do phác đồ bắt buộc, đây là tổn thương do dùng sai chỉ định, sai liều và sai thẩm quyền (tự ý mua).
- o **Nguy cơ thứ hai: Thiên lệch đổ lỗi (Blaming Bias) đối với dược sĩ cơ sở và bệnh nhân**
 - o *Phân tích:* Dàn ý hiện tại đang chĩa mũi dùi khá nhiều vào sự thiếu hiểu biết của bệnh nhân và sự háms lợi của nhà thuốc tư nhân. Điều này đúng, nhưng chưa đủ và thiếu tính khách quan của một nhà dịch tễ học.
 - o *Khuyến nghị:* Em đã bỏ qua "phần chìm của tảng băng trôi" – đó là sự quá tải của hệ thống y tế công lập. Nhiều bệnh nhân (đặc biệt ở tuyến huyện/xã) không thể chờ đợi hàng giờ để khám một cơn ho, sốt thông thường, buộc họ phải tìm đến giải pháp OTC nhanh chóng. Đừng chỉ phán xét đạo đức của nhà thuốc, hãy nhìn nhận nó như một hệ quả của cấu trúc cung ứng y tế hiện tại.

2. Các luận điểm có nguy cơ cao bị "Ảo giác AI" (Hallucination) thao túng

Nếu em phụ thuộc vào AI để viết nội dung chi tiết, hãy cực kỳ cảnh giác với các mục sau, vì AI 100% sẽ bịa đặt thông tin để làm hài lòng em:

- o **Các số liệu thống kê dịch tễ học tại Việt Nam:** AI rất thích tự sáng tác ra các câu như *"Theo thống kê của Bộ Y tế năm 2023, 60% trẻ em dùng kem trộn..."* hoặc *"Nghiên cứu tại Bệnh viện Da liễu Trung ương cho thấy..."*. Thực tế, dữ liệu thống kê y tế quốc gia ở Việt Nam về vấn đề này còn khá rời rạc và không có sẵn công khai cho AI học.
- o **Các văn bản quy phạm pháp luật:** AI có thể tự chế ra số hiệu Nghị định, Thông tư, hoặc nhầm lẫn luật của Việt Nam với luật của các quốc gia khác (như FDA của Mỹ) khi nói về quy chế quản lý thuốc kê đơn (Rx).
- o **Mô tả Ca lâm sàng (Case study):** AI có thể tự vẽ ra một ca lâm sàng trông rất "thật" với đầy đủ sinh hiệu, chỉ số xét nghiệm hoocmon Cortisol, nhưng thực chất hoàn toàn vi phạm nguyên tắc sinh lý bệnh.

3. Ba nguồn tài liệu chính thống bắt buộc phải đối chiếu chéo (Cross-check)

Để đảm bảo tính pháp lý và tính chính xác về mặt học thuật cho tiểu luận, em bắt buộc phải tự tra cứu và trích dẫn từ 3 nguồn sau (không được phép dùng AI tạo ra nội dung này):

- o **Dược thư Quốc gia Việt Nam (Phiên bản mới nhất - 2022):** Sử dụng để trích dẫn chuẩn xác về cơ chế dược lý, chỉ định, chống chỉ định và liều lượng tiêu chuẩn của từng loại hoạt chất Corticoid.
- o **Thông tư số 52/2017/TT-BYT (và Thông tư 27/2021/TT-BYT sửa đổi):** Quy định chi tiết về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú. Đây là cơ sở pháp lý cốt lõi để phân tích hành vi bán thuốc không kê đơn là vi phạm pháp luật.
- o **Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Da liễu (Ban hành kèm Quyết định số 75/QĐ-BYT năm 2015) & Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Nội tiết - Chuyển hóa:** Sử dụng làm căn cứ chuyên môn để định nghĩa rõ ràng về các biến chứng lâm sàng do Corticoid thay vì lấy thông tin trôi nổi trên mạng.

2.3. Quá trình Đánh giá, Chỉnh sửa và Đối chiếu nguồn độc lập (Chống ảo giác y khoa)

Lĩnh vực y tế đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, nơi một thông tin sai lệch có thể dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng. Do đó, tôi áp dụng quy trình **kiểm chứng chéo (Cross-checking)** vô cùng **ngghiêm ngặt** đối với toàn bộ dữ liệu đầu ra của AI:

Nhận diện và loại bỏ "Ảo giác số liệu" (Data Hallucination): * *Tình huống:* Trong quá trình sinh văn bản, AI đã tự động tạo ra câu: *"Theo báo cáo của Bộ Y tế năm 2023, có đến 65% nhà thuốc bán Corticoid không cần đơn và 40% trẻ em từng sử dụng kem trộn chứa Corticoid"*.

- *Xử lý:* Nhận thức được AI có xu hướng ngụy tạo số liệu để làm tăng tính thuyết phục, tôi đã lập tức loại bỏ các con số này. Thay vào đó, tôi sử dụng hệ thống từ khóa MeSH do AI gợi ý (như Self Medication, Topical Corticosteroids/adverse effects) để truy cập vào **PubMed** và tìm kiếm các bài báo dịch tễ học thực tế được bình duyệt (Peer-reviewed) tại Việt Nam để thay thế.
- **Đối chiếu chéo pháp lý và dược lý (Fact-checking):**
 - *Về Dược lý:* Khi AI liệt kê cơ chế gây suy tuyến thượng thận cấp của Dexamethasone, tôi không sao chép nguyên văn mà mở **Dược thư Quốc gia Việt Nam (2022)** để đối chiếu lại chính xác chỉ định, chống chỉ định và dược động học của thuốc.
 - *Về Pháp lý:* AI có sự nhầm lẫn giữa quy chế quản lý thuốc kê đơn (Rx) của FDA (Mỹ) và Việt Nam. Tôi đã chủ động chỉnh sửa và trích dẫn trực tiếp từ **Thông tư số 52/2017/TT-BYT** của Bộ Y tế Việt Nam để phân tích các lỗ hổng trong việc bán thuốc tại các cơ sở y tế tư nhân.
- **Tái cấu trúc văn phong lâm sàng (Humanizing & Clinical Tone):**
 - AI thường có văn phong liệt kê máy móc hoặc phán xét một chiều (đổ lỗi hoàn toàn cho bệnh nhân/dược sĩ). Tôi đã biên tập lại, sử dụng góc nhìn đa chiều của Dược tễ học để viết lại đoạn phân tích nguyên nhân, bổ sung yếu tố "sự quá tải của hệ thống y tế công lập" để bài luận mang tính khách quan và nhân văn hơn.

2.4. Trích dẫn sản phẩm AI hợp chuẩn Liêm chính học thuật

Đề tuân thủ tuyệt đối quy tắc liêm chính học thuật của Đại học Quốc gia Hà Nội, tôi minh bạch hóa toàn bộ quá trình sử dụng AI trong việc xây dựng đề cương này theo chuẩn **APA 7th Edition**. Sự minh bạch không làm giảm giá trị bài viết, mà trái lại, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của người nghiên cứu:

- **Tuyên bố sử dụng AI (AI Usage Declaration) ở Lời nói đầu:**
 - *"Trong quá trình thực hiện tiểu luận này, tác giả đã sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (ChatGPT phiên bản GPT-4o) để hỗ trợ (1) xây dựng cấu trúc vĩ mô của đề cương và (2) trích xuất các từ khóa y khoa chuẩn quốc*

tế (MeSH terms) phục vụ tra cứu dữ liệu trên PubMed. Tác giả chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác lâm sàng, đối chiếu chéo thông tin và văn bản cuối cùng."

- **Trích dẫn trong bài (In-text Citation):**
 - Khi sử dụng AI để tổng hợp các nhóm tác dụng phụ của Corticoid dùng ngoài da để làm khung sườn tìm kiếm, tôi trích dẫn như sau: (OpenAI, 2024). Nội dung chi tiết sau đó được lấy từ Hướng dẫn chẩn đoán của Bộ Y tế.
- **Trích dẫn trong danh mục Tài liệu tham khảo (References):**
 - **Cú pháp chuẩn APA 7:** OpenAI. (2024). *ChatGPT* (Phiên bản GPT-4o) [Mô hình ngôn ngữ lớn]. <https://chat.openai.com/>
 - Các tài liệu đối chiếu chéo (Dược thư Quốc gia, Thông tư Bộ Y tế) được xếp lên ưu tiên hàng đầu trong danh mục tài liệu tham khảo chính thức.

PHẦN 3: Phân tích các vấn đề đạo đức học thuật khi sử dụng AI

Quá trình ứng dụng AI (ChatGPT/Gemini) để xây dựng đề cương nghiên cứu về "Lạm dụng Corticoid" đã bộc lộ rõ những thách thức đạo đức học thuật đặc thù trong khối ngành Khoa học Sức khỏe. Ranh giới giữa sự hỗ trợ đắc lực và sự vi phạm liên chính y khoa được thể hiện qua ba khía cạnh cốt lõi sau:

3.1. Ranh giới của sự "Ủy thác nhận thức" và Nguy cơ dung túng Thiên lệch (Bias)

- **Sự ủy thác hợp lý:** Việc sử dụng AI để hệ thống hóa một khối lượng kiến thức lớn, hoặc yêu cầu AI trích xuất các từ khóa chuẩn quốc tế (MeSH terms) phục vụ tra cứu PubMed là sự hỗ trợ công nghệ hợp đạo đức, giúp tiết kiệm thời gian cơ học.
- **Nguy cơ vi phạm (Dung túng Thiên lệch):** Nếu tôi giao phó toàn bộ việc đánh giá nguyên nhân lạm dụng cho AI, tôi rất dễ rơi vào "**Thiên lệch đổ lỗi**" (**Blaming Bias**). Như Hội đồng phản biện đã chỉ ra ở Phần 2, AI có xu hướng phân tích bề nổi (đổ lỗi cho nhà thuốc hám lợi, bệnh nhân thiếu hiểu biết) mà bỏ qua nguyên nhân hệ thống (sự quá tải của y tế tuyến cơ sở). Việc sinh viên y khoa vay mượn góc nhìn hời hợt này của máy móc, thiếu đi sự thấu cảm và nhân quan dịch tễ học thực tiễn, chính là một sự vi phạm nghiêm trọng về đạo đức nghiên cứu.

3.2. Đạo đức thông tin: "Ảo giác AI" (Hallucination) và Hiểm họa trong Y khoa

Khác với các ngành khoa học xã hội, một thông tin sai lệch trong Y học có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Quá trình tương tác cho thấy AI tạo sinh tiềm ẩn những "ảo giác" chết người:

- **Nguy tạo bằng chứng lâm sàng:** AI sẵn sàng bịa ra các số liệu thống kê không có thật (ví dụ: "*60% trẻ em dùng kem trộn*") hoặc tự vẽ ra các ca bệnh lâm sàng về suy tuyến thượng thận cấp trông rất hoàn hảo nhưng sai lệch sinh lý bệnh.

- **Trách nhiệm đạo đức:** Nếu sinh viên đưa những số liệu "ảo" này vào tiểu luận hoặc dùng làm căn cứ đề xuất chính sách y tế mà không kiểm chứng, đó không chỉ là đạo văn (Plagiarism) hay gian lận học thuật, mà còn vi phạm nguyên tắc tối thượng của y khoa: "*Primum non nocere*" (Trước tiên là không làm hại).

3.3. Sở hữu trí tuệ và Tính minh bạch của nguồn dẫn chứng (Cross-checking mandate)

- **Sự mập mờ của AI:** Các mô hình ngôn ngữ lớn cào dữ liệu từ hàng triệu tài liệu y khoa nhưng không có khả năng trích dẫn chính xác nguồn gốc (tác giả, năm xuất bản, tạp chí). Trong khi đó, các phác đồ điều trị hay quy chế quản lý thuốc (như quy định bán thuốc Rx) luôn đòi hỏi tính pháp lý khắt khe.
- **Giải pháp đạo đức (Minh bạch hóa):** Sinh viên bắt buộc phải coi kết quả của AI chỉ là "bản nháp định hướng". Mọi tuyên bố về dược lý hay quy chế pháp luật đều phải được đối chiếu chéo (Cross-check) và trích dẫn ngược lại từ các nguồn học thuật chính thống (như *Dược thư Quốc gia Việt Nam 2022*, *Thông tư 52/2017/TT-BYT*). Đồng thời, việc sử dụng AI phải được khai báo minh bạch theo chuẩn APA ở cuối bài tiểu luận.

Kết luận: AI là một trợ lý nghiên cứu xuất sắc nhưng là một chuyên gia y tế tồi. Đạo đức học thuật trong kỷ nguyên AI không chỉ nằm ở việc "không chép bài của máy", mà là năng lực hoài nghi khoa học, giữ vững tư duy phản biện lâm sàng để kiểm duyệt nghiêm ngặt mọi thông tin trước khi áp dụng vào thực tế y khoa.

Phần 4: Bộ nguyên tắc cá nhân về cách sử dụng AI có trách nhiệm trong học tập

Là một sinh viên năm thứ 4 khối ngành Khoa học Sức khỏe tại ĐHQGHN – những nhân viên y tế tương lai chịu trách nhiệm trực tiếp về sức khỏe con người, tôi tự thiết lập **Hệ thống 6 nguyên tắc vàng** sau đây khi tương tác với AI tạo sinh. Bộ nguyên tắc này dịch chuyển từ tư duy "sử dụng công nghệ" sang tư duy "bảo vệ đạo đức và lâm chính y khoa":

4.1. Nguyên tắc 1: Tư duy lâm sàng độc lập và Khách quan (Overcoming Blaming Bias)

- **Nội dung:** Tôi luôn tự phác thảo mục tiêu nghiên cứu và cấu trúc luận điểm trước khi mở AI, đồng thời chủ động kiểm soát góc nhìn để tránh các bias thiên lệch tư duy do máy móc áp đặt.
- **Hành động thực tế:** Khi phân tích nguyên nhân lạm dụng Corticoid, tôi sẽ không "vơ đũa cả nắm" để đổ lỗi hoàn toàn cho nhà thuốc hay bệnh nhân theo gợi ý bề nổi của AI. Tôi sẽ chủ động đưa góc nhìn hệ thống vào bài viết: Phân tích sự quá tải của y tế công lập và rào cản tiếp cận y tế tuyến cơ sở.

4.2. Nguyên tắc 2: Hoài nghi lâm sàng tuyệt đối (Zero-Trust in AI Data)

- **Nội dung:** Tôi coi mọi số liệu thống kê dịch tễ, tên đề tài, cơ chế sinh lý bệnh hay ca lâm sàng (Case study) do AI tự tạo ra đều là "**ngụy tạo**" cho đến khi tự mình chứng minh được điều ngược lại.

- **Hành động thực tế:** Tuyệt đối không trích dẫn bất kỳ con số phần trăm (%) hay số liệu ca mắc bệnh nào từ cửa sổ chat của AI. Nếu AI gợi ý cấu trúc, tôi sẽ để trống phần số liệu và tự mình đi tìm câu trả lời thực tế.

4.3. Nguyên tắc 3: Bắt buộc đối chiếu chéo bằng chứng (Evidence-Based Cross-Checking)

- **Nội dung:** Tôi cam kết mọi thông tin chuyên ngành đưa vào bài luận phải được xác thực bằng các nguồn tài liệu chính thống có giá trị pháp lý và học thuật cao nhất trong ngành Y - Dược.
- **Hành động thực tế:** Sử dụng các từ khóa chuẩn quốc tế (MeSH terms) do AI gợi ý để tự tra cứu trên PubMed/Cochrane. Đồng thời, đối chiếu thủ công các luận điểm về dược lý với *Dược thư Quốc gia Việt Nam 2022* và các khía cạnh pháp lý với *Thông tư 52/2017/TT-BYT* của Bộ Y tế.

4.4. Nguyên tắc 4: Bảo mật thông tin bệnh nhân và Dữ liệu lâm sàng (Medical Privacy Boundaries)

- **Nội dung:** Tôi tuyệt đối không tải lên (upload) các dữ liệu nhạy cảm liên quan đến bệnh án thực tế, danh tính bệnh nhân, hoặc các tài liệu chuyên môn nội bộ chưa công bố của bệnh viện thực tập lên các mô hình AI công cộng.
- **Hành động thực tế:** Khi cần AI hỗ trợ sửa lỗi ngữ pháp hoặc tối ưu câu văn cho một ca lâm sàng cụ thể, tôi sẽ mã hóa hoặc giả định hóa toàn bộ thông tin (Ví dụ: Thay tên thật bằng "Bệnh nhân nhi, 5 tuổi, tiền sử viêm phế quản co thắt").

4.5. Nguyên tắc 5: Minh bạch liên chính và Trích dẫn chuẩn mực (Radical Transparency)

- **Nội dung:** Tôi chủ động công khai mức độ và phạm vi tham gia của AI trong sản phẩm học thuật của mình một cách trung thực nhất.
- **Hành động thực tế:** Khai báo rõ ràng ở phần Phụ lục hoặc Danh mục tài liệu tham khảo theo định dạng APA 7th Edition: "*Mô hình ChatGPT-4o được sử dụng để hỗ trợ tìm kiếm từ khóa MeSH và định hình cấu trúc vĩ mô của đề cương.*"

4.6. Nguyên tắc 6: Giữ vững nguyên tắc "Không làm hại" (Ultimate Ethical Responsibility)

- **Nội dung:** Tôi là người duy nhất ký tên vào bài nộp và chịu 100% trách nhiệm trước Nhà trường và Hội đồng đạo đức về tính chính xác của nội dung. Tôi khắc cốt ghi tâm nguyên tắc tối cao của ngành Y: *Primum non nocere* (Trước tiên là không làm hại).
- **Hành động thực tế:** Không sử dụng các đoạn văn do AI tự động viết (Copy-Paste). Tôi sẽ tự viết lại toàn bộ bằng ngôn ngữ học thuật của chính mình để đảm bảo rằng, nếu có bất kỳ một lời khuyên sức khỏe hay kiến thức lâm sàng nào trong bài luận, đó phải là kiến thức đã được bộ não của tôi hiểu, lọc và chịu trách nhiệm.

4.7. Tóm tắt bộ nguyên tắc cá nhân bằng Ma trận hành động

Rủi ro đạo đức & Lỗi hổng logic (Phần 3)	Nguyên tắc ứng phó (Phần 4)	Hành động kiểm soát cụ thể
Thiên lệch đổ lỗi (Blaming Bias)	Nguyên tắc 1	Tự bổ sung phân tích hệ thống (sự quá tải y tế cơ sở), không phụ thuộc vào góc nhìn một chiều của AI.
Ảo giác số liệu / Ca lâm sàng giả	Nguyên tắc 2 & 3	Loại bỏ 100% số liệu do AI viết; tự tra cứu <i>Được thư Quốc gia và Thông tư Bộ Y tế</i> .
Lạm dụng từ khóa / Đạo văn	Nguyên tắc 3 & 5	Dùng MeSH terms để tự đọc tài liệu gốc trên PubMed; trích dẫn nguồn AI minh bạch theo chuẩn APA 7th.
Rò rỉ thông tin bệnh án	Nguyên tắc 4	Giả định hóa và mã hóa mọi thông tin lâm sàng trước khi gửi cho AI.
Lười biếng nhận thức (Mất tư duy phản biện)	Nguyên tắc 6	Đóng vai trò là "Tổng biên tập lâm sàng", tự viết lại bằng giọng văn cá nhân dựa trên nguyên tắc <i>Không làm hại</i> .

Phần 5: Tạo 1 Infographic minh họa “ Sử dụng AI có trách nhiệm trong học tập ”(Dành cho công cụ Canva)

- **Chủ đề (Theme):** Y tế / Chuyên gia Lâm sàng.
- **Màu sắc chủ đạo:** Xanh dương y tế (Navy Blue/Medical Blue), Trắng và Đỏ (dùng để nhấn mạnh các cảnh báo rủi ro).
- **Công cụ sử dụng:** Canva
- **Tiêu đề chính (Header):** “*Sử dụng AI trong nghiên cứu Y khoa: Bộ 6 Nguyên Tắc Vàng Dành Cho Sinh Viên Khối Ngành Sức Khỏe*”
- **Nội dung chi tiết các Block trong Infographic:**

1. TƯ DUY LÂM SÀNG ĐỘC LẬP (OVERCOMING BIAS)

- *Icon gợi ý:* Hình bộ não kết hợp ống nghe y tế.
- *Nội dung Text:* Tự phác thảo mục tiêu nghiên cứu và góc nhìn dịch tễ học trước khi dùng AI. Tuyệt đối không để AI dẫn dắt tư duy, tránh bẫy "Thiên lệch đổ lỗi" (Blaming Bias) khi đánh giá hệ thống y tế.

2. HOÀI NGHI LÂM SÀNG TƯƠNG ĐỐI (ZERO-TRUST)

- *Icon gợi ý:* Kính lúp soi vào biểu tượng AI có dấu X đỏ.
- *Nội dung Text:* Mọi số liệu thống kê dịch tễ, ca bệnh lâm sàng do AI tạo ra đều bị coi là "**Ngụy tạo**" (**Hallucination**) cho đến khi bạn tự chứng minh được điều ngược lại.

3. ĐỐI CHIẾU CHÉO BẰNG CHỨNG (FACT-CHECKING)

- *Icon gợi ý:* Biểu tượng quyển sách (Dược thư) và cán cân luật pháp.
- *Nội dung Text:* Chỉ tin tưởng tài liệu chính thống. Mọi cơ chế dược lý, quy chế pháp luật từ AI phải được đối chiếu với **Dược thư Quốc gia** và **Văn bản Bộ Y tế**.

4. BẢO MẬT DỮ LIỆU BỆNH NHÂN (MEDICAL PRIVACY)

- *Icon gợi ý:* Hồ sơ bệnh án có ổ khóa bảo mật.
- *Nội dung Text:* Tuyệt đối **KHÔNG** tải lên (upload) thông tin cá nhân của bệnh nhân, bệnh án thực tế hoặc tài liệu nội bộ của bệnh viện lên các "hộp đen" AI công cộng.

5. MINH BẠCH LIÊM CHÍNH (RADICAL TRANSPARENCY)

- *Icon gợi ý:* Dấu mộc/Chứng nhận APA.
- *Nội dung Text:* Chủ động khai báo trung thực mức độ sử dụng AI (VD: dùng để tìm từ khóa MeSH, lập dàn ý) trong danh mục tài liệu tham khảo theo đúng chuẩn **APA 7th Edition**.

6. NGUYÊN TẮC "KHÔNG LÀM HẠI" (PRIMUM NON NOCERE)

- *Icon gợi ý:* Biểu tượng chữ thập y tế trên chiếc khiên.
- *Nội dung Text:* Sinh viên là người duy nhất ký tên vào bài nộp. Phải chịu 100% trách nhiệm về tính chính xác lâm sàng, **không đổ lỗi cho AI** nếu có sai sót kiến thức.

Footer (Chân trang):

- *Dòng chữ nhỏ:* Phụ lục đính kèm tiêu luận: "Thực trạng lạm dụng Corticoid tại Việt Nam"
- *Tác giả:* [Tên của bạn] - Sinh viên năm 4 Khối ngành Khoa học Sức khỏe, ĐHQGHN.



Hình 1: mô tả hướng dẫn sử dụng AI có trách nhiệm và bảo mật dữ liệu lâm sàng cho sinh viên khối ngành Khoa học Sức khỏe.

